

Evaluación inicial (ABCDE del trauma)

1. Introducción y relevancia clínica

El trauma es una de las **principales causas de muerte en menores de 45 años** y la primera en adultos jóvenes. En Chile, representa una causa significativa de **mortalidad evitable**, especialmente por **accidentes de tránsito y violencia interpersonal**.

El **manejo inicial del paciente politraumatizado** debe ser rápido, sistemático y eficiente, con el objetivo de **identificar y tratar lesiones que amenazan la vida de inmediato**.

Este manejo se basa en los principios del **ATLS (Advanced Trauma Life Support)** y las recomendaciones del **MINSAL Chile (Guía de manejo del paciente politraumatizado 2022)**.

El eje del enfoque es el **método ABCDE**, que prioriza la estabilización de las funciones vitales por sobre el diagnóstico definitivo.

- En EUNACOM, las preguntas sobre trauma suelen evaluar la **secuencia correcta del ABCDE**, el reconocimiento de **signos de shock**, y **cuándo intervenir o derivar** según los hallazgos iniciales.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. Conceptos básicos

El trauma produce una cascada de respuestas sistémicas que afectan la perfusión y oxigenación tisular.

Las **tres causas de muerte prevenible** más frecuentes son:

1. **Obstrucción de vía aérea.**
2. **Neumotórax a tensión.**
3. **Hemorragia no controlada.**

2.2. Principio de priorización

El enfoque ABCDE responde al principio de:

“Tratar primero lo que mata primero.”

Cada paso debe completarse antes de pasar al siguiente, y si se identifica una amenaza vital, se debe **intervenir de inmediato** antes de continuar la secuencia.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

El **examen primario** tiene como objetivo **detectar y tratar lesiones letales**.

A continuación, se detalla la secuencia **ABCDE** con sus hallazgos clínicos más relevantes.

A. Airway (vía aérea) con control de la columna cervical

Objetivo:

Garantizar una **vía aérea permeable** y proteger la **columna cervical**.

Evaluación:

- ¿El paciente **habla o responde verbalmente**? → vía aérea permeable.
- Observar signos de obstrucción:
 - Estridor, ronquidos, gorgoteo.
 - Deformidad facial, sangrado oral, vómito.

Acciones:

1. **Alineación en bloque** de cabeza y cuello.
2. **Extracción de cuerpos extraños o secreciones.**
3. **Aspiración de cavidad oral.**
4. **Colocar cánula orofaríngea o nasofaríngea** si paciente inconsciente sin reflejo nauseoso.
5. **Intubación orotraqueal** si compromiso de conciencia ($GCS \leq 8$) o riesgo de obstrucción.
6. **Si falla intubación:** cricotiroidotomía o traqueostomía de urgencia.

No hiperextender el cuello hasta descartar lesión cervical.

B. Breathing (respiración y ventilación)

Objetivo:

Evaluar y corregir alteraciones de la ventilación y oxigenación.

Evaluación:

- Frecuencia respiratoria.
- Movimiento torácico simétrico.
- Saturación de O₂ (SpO₂).
- Auscultación bilateral: ruidos disminuidos, asimétricos o crepitantes.
- Percusión: timpanismo o matidez.

Lesiones letales a identificar:

1. **Neumotórax a tensión.**
2. **Neumotórax abierto.**
3. **Hemotórax masivo.**
4. **Tórax inestable (volet costal).**
5. **Taponamiento cardíaco.**

Intervenciones inmediatas:

- **Oxígeno al 100% (mascarilla o bolsa-válvula).**
- **Drenaje pleural (tubo torácico)** si neumotórax o hemotórax.
- **Sellado de heridas abiertas (válvula unidireccional).**
- **Toracotomía** si taponamiento cardíaco (si no responde a líquidos).

C. Circulation (circulación y control de hemorragias)

Objetivo:

Identificar y controlar **hemorragias que amenazan la vida**.

Evaluación:

- Nivel de conciencia.
- Pulso: frecuencia, amplitud, llenado capilar.
- Presión arterial (hipotensión = shock).
- Piel: pálida, fría, sudorosa.
- Buscar hemorragia externa (cuero cabelludo, tórax, abdomen, pelvis, extremidades).

Intervenciones:

1. **Presión directa** sobre sangrados externos.
2. **Torniquete** solo si sangrado no controlable.
3. **Dos accesos venosos gruesos (14–16G)**.
4. **Reposición con cristaloides tibios (Ringer Lactato o SF 0,9%)**.
5. Si persiste shock → transfusión de **hemoderivados (relación 1:1:1)**.
6. **Control del foco hemorrágico** (quirúrgico si interno).

Las **hemorragias internas ocultas** más frecuentes:
Tórax, abdomen, pelvis, fémur.

D. Disability (déficit neurológico)

Objetivo:

Evaluar el **estado neurológico y perfusión cerebral**.

Evaluación:

- **Escala de Glasgow (GCS):**
 - 15: normal
 - ≤8: compromiso grave → intubación.

- **Reacción pupilar:** tamaño, simetría y reactividad.
- **Signos de lateralización** (hemiparesia, desviación ocular).
- **Glucemia capilar:** descartar hipoglicemia.

Recordar la “tríada de Cushing” (bradicardia, hipertensión, respiración irregular): indica hipertensión intracraneal.

E. Exposure (exposición y control del entorno)

Objetivo:

Exposición completa del paciente para evaluar todas las lesiones, **sin comprometer la temperatura.**

Evaluación:

- Retirar ropa completamente.
 - Buscar heridas, equimosis, deformidades.
 - Palpar columna, pelvis, extremidades.
 - **Control de temperatura:** evitar hipotermia (mantas térmicas, fluidos tibios).
-

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

Durante el examen primario

Solo exámenes que **no retrasen el tratamiento:**

- **Glicemia capilar.**
- **Oximetría de pulso.**
- **TAC de cuerpo completo (“pan-TAC”)** posterior a estabilización.
- **Ecografía FAST:** detectar hemoperitoneo o hemotórax.
- **Radiografía de tórax y pelvis.**

- **Hemograma, gasometría y pruebas cruzadas.**
-

Criterios de trauma grave (según MINSAL):

- Glasgow <13.
- Presión sistólica <90 mmHg.
- Frecuencia respiratoria <10 o >29/min.
- Saturación <90%.
- Trauma penetrante en cabeza, cuello, tórax o abdomen.
- Fractura abierta de pelvis o fémur.
- Dos o más fracturas largas.
- Eyectado de vehículo o atropello de peatón.

Todo paciente con trauma grave debe ingresar a **unidad de trauma o pabellón**.

5. Tratamiento (según Guías MINSAL / ATLS 10^a edición)

5.1. Medidas iniciales

1. **Evaluar seguridad del entorno.**
2. **Control cervical inmediato.**
3. Aplicar el **ABCDE** con intervenciones simultáneas.
4. **Monitorización básica:** ECG, saturación, presión arterial, temperatura.
5. **Oxígeno suplementario.**
6. **Vía venosa gruesa bilateral.**
7. **Cristaloides tibios (500–1000 mL adultos, 20 mL/kg niños).**

8. **Sonda urinaria** (si no hay sospecha de trauma uretral).
 9. **Sonda nasogástrica** (contraindicada si fractura de base de cráneo).
-

5.2. Reanimación y control de daños

- **Hemorragia externa:** presión directa o torniquete.
- **Hemotórax/Neumotórax:** drenaje pleural.
- **Hemorragia interna:** cirugía o embolización.
- **Transfusión masiva:** si Hb <7 o shock persistente.
- **Prevención de tríada letal:** hipotermia, acidosis, coagulopatía.

Reanimar con **sangre y plasma**, no solo cristaloides, en trauma severo.

5.3. Examen secundario

Tras estabilización inicial:

- Evaluación cefalocaudal completa.
 - Historia AMPLE (Alergias, Medicamentos, Patologías, Última comida, Eventos).
 - Estudios de imagen avanzados (TAC).
 - Plan terapéutico definitivo.
-

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Causa	Prevención / Manejo
Hipoxia / obstrucción	Falta de control de vía aérea.	Asegurar A tempranamente.

Neumotórax a tensión	No drenaje oportuno.	Descompresión inmediata.
Shock hipovolémico	Hemorragia no controlada.	Control de foco + transfusión.
Hipotermia y acidosis	Exposición prolongada.	Abrigar, fluidos tibios.
Coagulopatía por dilución	Exceso de cristaloides.	Usar protocolo transfusional balanceado.
Retraso diagnóstico de lesiones ocultas	Falta de examen secundario.	Reevaluar continuamente.

Pronóstico:

- Determinado por la **rapidez en ABCDE** y control de sangrado.
- Mortalidad evitable hasta en 30% si hay demoras.
- El manejo estructurado reduce significativamente la morbilidad.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. **ABCDE es la base de todo manejo de trauma.**
2. **El examen es dinámico:** repetir ABCDE tras cada intervención.
3. **FAST positivo = hemoperitoneo hasta demostrar lo contrario.**
4. **No demorar cirugía por estudios complementarios.**

5. **Taponamiento cardíaco → triada de Beck (hipotensión, ruidos apagados, ingurgitación yugular).**
 6. **El trauma pélvico puede esconder grandes pérdidas sanguíneas.**
 7. **Prioridad: vía aérea permeable con control cervical.**
-



Errores comunes

- Saltarse pasos del ABCDE (ej. evaluar circulación antes de vía aérea).
 - Mover al paciente sin inmovilizar columna cervical.
 - Retirar casco sin control cervical.
 - Usar grandes volúmenes de cristaloides fríos.
 - No reevaluar signos vitales tras intervenciones.
 - Olvidar exposición completa del paciente.
 - Demorar cirugía por solicitud de TAC innecesario.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **ABCDE** es el pilar del manejo inicial del trauma.
2. **A:** asegurar vía aérea y proteger columna cervical.
3. **B:** corregir hipoxia y lesiones torácicas letales.
4. **C:** controlar hemorragias y restaurar perfusión.
5. **D:** evaluar conciencia y reflejos pupilares.
6. **E:** exponer completamente al paciente, evitando hipotermia.
7. El objetivo es **salvar la vida, no diagnosticar todo en la primera hora.**